アリドネパッチで
食欲は改善するのか？

ドネペジル貼付剤と食欲・体重の実際

医知創造ラボ　今村久司

最新エビデンスに基づく批判的吟味

今日のテーマ

アリドネパッチで食欲が改善した

という報告があるが、本当か？

- ドネペジルは食欲を上げる薬？
- 食欲改善報告の中身と限界
- 貼付剤の消化器副作用の実態
- 実臨床での判断基準

ドネペジルと食欲 — そもそもの前提

ドネペジル（アリセプト）は食欲を「下げる」方向の薬

電子添文に食欲不振・悪心・嘔吐・下痢・体重減少を記載

3mg開始は「消化器副作用を抑えるための非有効量」

Soysal 2016 メタアナリシス

ChEI使用は認知症高齢者の
体重減少と有意に関連

JNNP 2016;87:1368-74

Sheffrin 2015 VAコホート

ChEI群	29.3%
対照群	22.8%
HR	1.23

JAGS 2015;63:1512-8

食欲改善報告 — 吉元 2025年論文

『診療と新薬』2025;62(10):701-5　単施設・後ろ向き観察研究　n=40

対象	AD 40例（前治療薬なし）
MMSE	24週で有意変化なし
SNAQ	**6.7 → 17.2（16週後）**
食事摂取量	**157.9%（16週後）**
副作用	皮膚障害 12.5%、胃腸障害 0%

→ 著者は「食欲改善が認められた」と結論

この研究の限界 — そのまま信じてよいのか？

対照群がない

経口群・未治療群との比較がなく、
薬の効果か自然経過か区別できない

少数例

SNAQ解析 18例、食事摂取量 10例
→ 統計的検出力が低い

後ろ向き・単施設

症例選択バイアスを排除できない

交絡因子

スタッフの声かけ、介護環境の変化が
食欲に影響した可能性

貼付剤の消化器副作用の実態

「貼り薬だから消化器副作用は起きない」は誤り

有害事象	パッチ群	経口群
胃腸障害全体	**9.8%**	**8.4%**
適用部位紅斑	24.9%	—
適用部位そう痒感	22.5%	—
接触皮膚炎	11.0%	—

副作用がなくなるのではなく、副作用の重心が皮膚側に移る製剤

Nakamura Y, et al. Geriatr Gerontol Int 2023

なぜ「食べるようになった」と見えるのか

吉元論文は全例新規開始（前治療薬なし）・胃腸障害 0例

→ 「経口剤の消化器不快軽減」仮説はこの研究には当てはまらない

著者の考察（薬理学的仮説）

- 💊 嚥下機能の改善（ACh濃度↑）
- 🔬 抗炎症効果（サイトカイン抑制）
- 👃 嗅覚・味覚の改善
- 📈 貼付剤の緒やかな血中濃度上昇

交絡因子（排除できない）

- 🏥 スタッフの声かけ・介護環境
- 🔄 全身状態の自然変動
- ❓ プラセボ効果

※ 経口→貼付剤の切り替え場面では、消化器不快軽減が寄与する可能性あり（別の仮説）

切り替えを検討する患者像

経口ドネペジルで 消化器症状が問題	悪心・食欲不振・下痢が持続 減量でも改善しない
内服アドヒアランス が不安定	飲み忘れが頻回 服薬拒否がある
嚥下機能低下	経口投与自体にリスク 誤嚥性肺炎の既往
介護負担の軽減	服薬介助の負担が大きい 施設入所で管理を簡便化
「何となく食が 細くなった」	明確な消化器症状はないが 食事量が漸減している

貼付剤使用時の注意点

- 同一部位への貼付は 7日以上空ける（ローテーション）
- 剥離後 3週間は直射日光を避ける（光線過敏）
- 適用部位紅斑 24.9%、そう痒感 22.5%、接触皮膚炎 11.0%
- 皮膚トラブルが強い患者には不向き

Take-Home Message

1. アリドネパッチは「食欲増進薬」ではない
2. 食欲改善報告はあるが、エビデンスレベルは低い
3. 貼付剤でも消化器副作用は残る
4. 改善の主因は「経口剤の不快軽減」と考えるのが妥当
5. 消化器症状・服薬困難例での切り替え先として位置づける